

技術操作站教案

止血帶轉換 / 降位 + 鑷式擔架-教學內容參考三、六~十一；教學流程參考四

一、課程基本資訊

主題	止血帶轉換 / 降位 + 鑷式擔架操作
對象 / 人數	學員 20 人
指導員	1 人
總時長	50 分鐘 (講解示範 15 分 + 操作 15*2 分 + 討論 5 分)
站別性質	純技術操作站
器材	止血帶 ×20、止血模組 ×4、鑷式擔架 ×2(含專屬頭部固定器)

二、教學目標

1. 正確操作止血帶之施打、降位與轉換 (以止血模組打包傷口後改用加壓敷料)。
2. 運用「酒到斷 so good」口訣，判斷該不該執行止血帶轉換 / 降位。
3. 正確分工與口令，完成鑷式擔架之組裝、上傷患與搬運。
4. 示範頸部與腋下出血的固定敷料方式(可參考影片)。

三、核心口訣：止血帶轉換 / 降位時機「酒到斷 so good」

提醒：除「綁太久」是考慮降位 / 轉換的時機外，其餘四項皆為「維持止血帶、不要轉換」的情境。

口訣	情境	說明	處置	理由
酒 (久)	綁太久	綁太久不換、綁不久快換。	考慮降位.轉換	降低肢體缺血傷害
到	快到院	後送時間短、快到院	不轉換	
斷	斷肢	創傷性截肢	不轉換	出血量大、無法有效加壓止血
so (休)	休克	血行動力學不穩定	不轉換	轉換失敗將惡化休克
good (顧)	顧不到	大量傷患、無法持續監測傷口	不轉換	轉換後需密切監測，人力不足易漏看再出血

四、教學流程 (50 分鐘)

時間	階段	內容
0-13 分	講解 + 示範	全組集中，講完口訣與關鍵動作。 示範一次正確「上止血帶→降位 / 轉換」與鑷式分合。
13-15 分	分組	20 人切兩大組各 10 人：A 組止血帶站、B 組鑷式站
15-30 分	第一輪操作	A 組@止血帶站、B 組@鑷式站（同時進行）
30-31 分	換站	兩組人員互換
31-45 分	第二輪操作	兩組互換後再練一輪
46-50 分	討論與總結	QA 與回饋時間

五、器材流量與分站安排

器材	分站安排
止血帶 ×20	人手一條，全班可同時練上帶
止血模組 ×4	2 人 1 組都要練習到降位與轉換
鑷式擔架 ×2	10 人分 2 小隊各 5 人；輪流當操作者 / 傷患 / 喊口令

指導員配置：置中學員操作即可。

六、規格 (Ferno SCOOP EXL) (依 Ferno SCOOP EXL 原廠手冊；其他型號規格請另行確認)

載重能力	227 kg (500 lb / 36 st)
重量	8 kg
長度 (4 段可調)	1647 / 1770 / 1890 / 2010 mm (最長約 2100 mm)
折疊長度	1200 mm
寬度	432 mm
厚度	展開 70 mm / 折疊 80 mm
材質	HDPE 高密度聚乙烯 (TSL 鎖為不鏽鋼)

講解重點只需強調三項：載重 227kg、長度 4 段可調、可縱向分兩半。

七、結構 (6 元件)

1. 吊抬把手 ×4 (頭端 2、腳端 2) ——抬運用
2. 側邊把手 ×8 (每側 4) ——內含固定帶掛鉤插銷
3. 小側孔 ×2——固定 365-E 頭部固定器的 H 形魔鬼氈帶
4. TSL 雙重安全鎖 ×2 組 (頭端、腳端各一) ——縱向分兩半的關鍵
5. 側邊鎖定把手 ×2——調長度
6. 固定帶掛鉤插銷 ×8
(記法：「把手抬、側孔固頭、TSL 分合、鎖桿調長」。)

八、使用步驟

1. 調長度：鎖桿扳上解鎖 → 拉腳段對病患身高 → 鎖桿扳下聽「喀」 → 拉腳段確認不滑動。
2. 分兩半：雙手握頭端把手 → 同按 TSL 兩鈕分離 → 腳端重複。
3. 置入：兩半自病患兩側貼地放入身下 (微抬不翻身)。
4. 閉合：頭端先接合 TSL → 腳端接合 → 拉動確認兩端都無法分開。

重點觀念：先扣頭端是因為頭端尺寸固定、可當基準，方便腳端再對位調長度。順序 (哪端先扣) 看現場、緊急時非必要；但「兩端都要扣 + 抬起前各拉動測試確認」絕不可省——沒「喀」、沒測就抬，兩半可能分離墜患。

5. 固定：上固定帶 (胸、腹 / 骨盆、腿至少三段) + 頭部固定器 (H 形魔鬼氈帶最後上)。
6. 抬運：抬前四確認 (扣好 / 病患固定好 / TSL 鎖好 / 卡桿鎖好) → 喊口令同步抬。

九、消毒注意事項

應做：

1. 每次使用後用布 + 非研磨性消毒劑擦拭；腿段伸最長、直立（腳端朝下）。
2. 清潔用溫水 + 肥皂 / 溫和清潔劑，軟刷去污並避開標籤。
3. 消毒清潔後必須完全乾燥才收；存放乾燥、室內、避免陽光直射。

禁止：

1. 不可高壓水沖洗。
2. 不可用漂白劑、酚類、碘（會損壞 HDPE）。

不可整支浸泡消毒劑。

十、鏟式擔架檢核表

用途：鏟式站無指導員時，由同儕逐項勾選；任一項 No 即喊停重做。

項	檢核要點	勾選
1.	依適當方式裝上頭部固定器。	☐ Yes ☐ No
2.	操作前檢查擔架卡榫、調整長度至傷患身高。	☐ Yes ☐ No
3.	縱向分離為左右兩半，自傷患兩側放置。（頸部對齊鏟單原孔）	☐ Yes ☐ No
4.	輕推傷患固定、由一側微抬，兩半依序插入身體下方	☐ Yes ☐ No
5.	頭端先扣合、再扣腳端，確認兩端卡榫到位（聽到聲響）	☐ Yes ☐ No
6.	扣合過程避免夾到傷患皮膚 / 衣物	☐ Yes ☐ No
7.	上固定帶（至少胸、腹 / 骨盆、腿三段）	☐ Yes ☐ No

十一、回饋重點 (鏟單與止血帶轉換/降位)

1. 止血帶常見錯誤：綁太鬆未壓住動脈、位置過低、未記錄上帶時間。
2. 轉換 / 降位判斷：再次強調「酒到斷 so good」中四項為『維持』情境，只有綁太久才考慮轉換。
3. 鏟式擔架常見錯誤：兩端卡榫未確實、固定帶不足等。
4. 安全提醒：小心學員閃到腰。